



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROGRAM PELAYANAN HIV/AIDS
RS PRIMA HUSADA
TAHUN 2026**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

**PROGRAM PELAYANAN HIV/AIDS
RS PRIMA HUSADA
TAHUN 2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

HIV/AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan global yang hingga saat ini masih menjadi perhatian dunia. HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, khususnya sel CD4 yang berperan penting dalam melawan infeksi. Apabila tidak mendapatkan pengobatan yang tepat, infeksi HIV dapat berkembang menjadi AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*), yaitu kondisi ketika sistem kekebalan tubuh mengalami kerusakan berat sehingga penderita rentan terhadap berbagai infeksi oportunistik dan penyakit lainnya.

Penularan HIV dapat terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh yang terinfeksi, seperti darah, sperma, cairan vagina, dan air susu ibu (ASI). Beberapa faktor yang menyebabkan penyebaran HIV antara lain hubungan seksual berisiko, penggunaan jarum suntik secara bergantian, transfusi darah yang terkontaminasi, serta penularan dari ibu kepada anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Meskipun berbagai upaya pencegahan dan pengobatan telah dilakukan, kasus HIV/AIDS masih ditemukan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai HIV/AIDS sangat penting untuk mengurangi stigma, mencegah penularan, dan meningkatkan kualitas hidup penderita. Selain itu, rumah sakit juga berperan dalam pelaksanaan surveilans, pencatatan dan pelaporan kasus HIV/AIDS melalui sistem nasional, serta pemberian terapi pada pasien ODHIV.

Program kerja pelayanan HIV/AIDS ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan HIV/AIDS yang komprehensif, meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta terintegrasi dengan program mutu dan keselamatan pasien.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV;
5. PMK No.27 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasyankes;
6. Kepdirjen Nomor Hk.01.07/MENKES/1596/.2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Direktorat Jendral No HK.02.02.D.43961.2024 Tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 059.1/RSPHS/I-KEP/DIR/I/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Prima Husada;
9. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pelayanan HIV/AIDS di rumah sakit dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, bermutu, aman, efektif, berkesinambungan, dan berorientasi pada pasien bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

2. Tujuan Umum

Mewujudkan pelayanan HIV/AIDS yang komprehensif, berkualitas, efektif, dan berkesinambungan untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat HIV/AIDS, mencegah penularan HIV, serta mendukung pencapaian program nasional penanggulangan HIV/AIDS sesuai standar akreditasi rumah sakit dan kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

3. Tujuan Khusus

- a. Menyelenggarakan layanan deteksi dini HIV melalui konseling dan tes HIV sesuai indikasi klinis dan standar pelayanan yang berlaku.
- b. Memberikan pelayanan pengobatan HIV dengan terapi antiretroviral (ARV) secara tepat, aman, dan berkesinambungan sesuai pedoman nasional.
- c. Menyelenggarakan pelayanan diagnosis, pengobatan, dan pemantauan infeksi oportunistik serta penyakit penyerta pada pasien HIV/AIDS.
- d. Meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan ARV melalui konseling, edukasi, pendampingan, dan pemantauan berkala.
- e. Mencegah terjadinya penularan HIV di fasilitas pelayanan kesehatan melalui penerapan kewaspadaan standar, pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), serta keselamatan pasien.
- f. Mendukung program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (*Prevention of Mother-to-Child Transmission/PMTCT*).
- g. Menjamin kerahasiaan informasi pasien serta mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap ODHA dalam seluruh proses pelayanan.
- h. Menyediakan pelayanan penunjang yang diperlukan, meliputi laboratorium, farmasi, gizi, kesehatan jiwa, dan layanan spesialisik lainnya sesuai kebutuhan pasien.
- i. Mengembangkan koordinasi dan sistem rujukan yang efektif dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit rujukan, dan jejaring layanan HIV/AIDS lainnya.
- j. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi program HIV/AIDS secara berkala sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan.
- k. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan HIV/AIDS melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
- l. Mendukung pemenuhan standar akreditasi rumah sakit terkait pelayanan pasien, program nasional, mutu pelayanan, dan keselamatan pasien dalam penyelenggaraan layanan HIV/AIDS.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

“Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat”

2.2 Misi

1. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat.
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

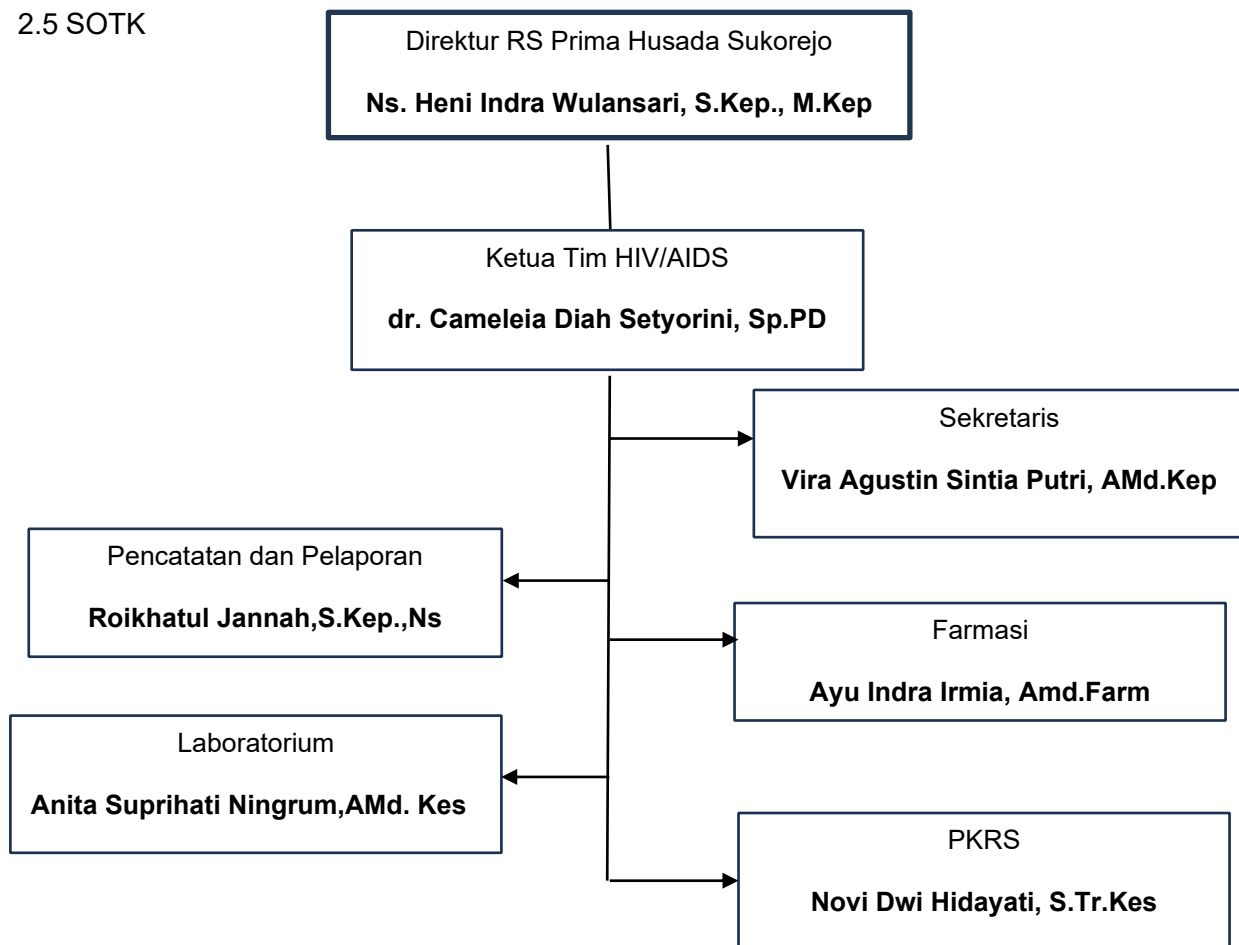
2.3 Motto

“Sahabat menuju sehat”

2.4 (7) Nilai Budi Utama

1. Jujur dipercaya
2. Tanggung jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 SOTK



**STRUKTUR ORGANISASI TIM HIV/AIDS
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO**

Tabel 2.5.1 Struktur Organisasi Tim HIV/AIDS Rs Prima Husada Sukorejo

Ketua Tim	:	dr. Cameleia Diah Setyorini, Sp.PD
Sekretaris	:	Vira Agustin Sintia Putri, A.md Kep
Anggota	:	
1. Pencatatan dan Pelaporan	:	Roikhatul Jannah., S.Kep.,Ns
2. Farmasi	:	Ayu Indra Irmia, A.md. Farm
3. Laboratorium	:	Anita Suprihatinigrum., Amd. Kes
4. PKRS	:	Novi Hidayati, S.Tr.Kes

Keterangan :

1. Ketua Tim
 - a. Melaksanakan pembinaan kualitas atau mutu profesi pelayanan.
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang keperawatan maupun kepala instalasi yang terkait dalam membina kualitas profesi pelayanan.
 - c. Mengendalikan dan mengevaluasi kualitas pelayanan profesi.
2. Perawat
 - a. Melakukan skrining pasien diawal masuk poli penyakit dalam/ poli vct.
 - b. Melakukan cek penandaan pasien dengan diagnose HIV/AIDS pada RM .
 - c. Melakukan koordinasi dengan tim HIV/AIDS dan Tim PPI dalam rangka kegiatan operasional.
 - d. Pengawasan terhadap SPO yang telah ditetapkan.
 - e. Melakukan evaluasi kegiatan operasional dan mutu pelayanan HIV/AIDS termasuk pencatatan dan pelaporan
3. Farmasi
 - a. Melaksanakan pelayanan obat untuk pasien ODHIV
 - b. Melakukan koordinasi dengan ketua tim HIV/AIDS dan tim medis lain.
 - c. Melaksanakan evaluasi terhadap kasus – kasus terkait obat HIV/AIDS
4. Laboratorium
 - a. Melaksanakan pelayanan pemeriksaan laboratorium terkait pelayanan HIV/AIDS
 - b. Pemantauan pelaporan pelayanan HIV/AIDS terkait hasil analisa laboratorium.
 - c. Melakukan koordinasi dengan ketua tim HIV/AIDS terkait dengan pelayanan HIV/AIDS
5. PKRS
 - a. Menyusun program promosi kesehatan terkait pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan HIV/AIDS di rumah sakit.
 - b. Menyusun dan menyediakan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai HIV/AIDS dalam bentuk leaflet, poster, banner, video edukasi, media sosial, dan media promosi lainnya.
 - c. Mendukung kegiatan konseling dan edukasi pasien HIV/AIDS bersama dokter, perawat, konselor HIV, dan tenaga kesehatan lainnya.

2.6 Permasalahan Kinerja Tahun 2025

NO	PROGRAM	PERMASALAHAN	KET
1.	Promosi Kesehatan	a. Media edukasi HIV/AIDS dan IMS belum diperbarui secara berkala. b. Penyuluhan HIV/AIDS kepada pasien, keluarga, dan pengunjung belum dilakukan secara rutin. c. Pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan HIV, IMS, PrEP, PEP, dan pentingnya tes HIV masih rendah. d. Stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV masih menjadi hambatan dalam promosi kesehatan. e. Dokumentasi kegiatan promosi kesehatan belum lengkap sebagai bukti pelaksanaan	
2.	Penemuan kasus HIV/AIDS a. Skrining HIV/AIDS b. Konseling pada pasien HIV/AIDS c. Identifikasi IMS pada pasien HIV/AIDS d. Skrining HIV/AIDS notifikasi pasangan e. Monitoring penelusuran kontak	a. Pelaksanaan skrining HIV pada pasien dengan faktor risiko atau kondisi indikasi belum mencapai target. b. Pengisian formulir skrining HIV belum lengkap dan belum seragam di seluruh unit pelayanan. c. Skrining IMS, sifilis (TPHA), pada pasien HIV belum dilakukan secara menyeluruh sesuai indikasi. d. Masih terdapat pasien yang menolak pemeriksaan HIV karena stigma dan kurangnya pemahaman. e. Koordinasi antara IGD, rawat jalan, rawat inap, laboratorium dan Poli VCT belum optimal sehingga terdapat keterlambatan rujukan internal	
3.	Penanganan kasus HIV/AIDS a. Tata laksana IO pada HIV/AIDS b. Pemberian Profilaksis c. Pengobatan IMS d. Terapi ARV e. Pemantauan kepatuhan dan Viral Load f. Rujukkan bila diperlukan	a. Sebagian pasien terlambat memulai terapi ARV setelah diagnosis ditegakkan. b. Kepatuhan minum ARV belum optimal sehingga berisiko terjadi putus obat (Lost to Follow Up/LTFU). c. Penatalaksanaan infeksi oportunistik dan IMS belum	

		terdokumentasi secara lengkap. d. Edukasi kepatuhan terapi, pencegahan penularan, dan gaya hidup sehat belum diberikan secara konsisten e. Pemantauan Viral Load belum dilakukan sesuai jadwal pada seluruh pasien yang memenuhi kriteria.	
4.	Survailens (pencatatan dan pelaporan)	a. Kelengkapan pencatatan register HIV/AIDS dan IMS belum mencapai 100%. b. Ketepatan waktu pelaporan ke SIHA masih belum konsisten. c. Masih terdapat ketidaksesuaian antara data pelayanan, register, dan laporan bulanan. d. Analisis tren kasus HIV/AIDS dan indikator program belum dilakukan secara rutin setiap bulan/triwulan. e. Monitoring indikator mutu program HIV/AIDS belum dilaksanakan secara berkala. f. Hasil monitoring dan evaluasi belum selalu ditindaklanjuti dengan rencana perbaikan yang terdokumentasi	
5.	Manajemen Program	a. Jumlah tenaga yang telah mengikuti pelatihan HIV/AIDS (VCT, PITC, PDP, IMS, SIHA) masih terbatas sehingga kompetensi petugas belum merata. b. Koordinasi lintas unit (IGD, Rawat Jalan, Rawat Inap, Laboratorium, Farmasi, Rekam Medis) belum berjalan optimal sehingga alur pelayanan belum efektif c. Kerja sama dengan Dinas Kesehatan, puskesmas, LSM, dan rumah sakit rujukan belum terdokumentasi secara lengkap d. Perencanaan kebutuhan obat ARV, reagen laboratorium, test kit HIV, dan logistik IMS belum berbasis konsumsi sehingga berpotensi terjadi kekosongan stok e. Monitoring dan evaluasi program belum dilakukan secara berkala sesuai jadwal yang ditetapkan.	

		f. Pelaporan program HIV/AIDS ke SIHA maupun laporan internal rumah sakit belum selalu tepat waktu dan lengkap g. Rapat koordinasi program HIV/AIDS belum dilaksanakan secara rutin dan belum menghasilkan rencana tindak lanjut yang terdokumentasi	
--	--	--	--

BAB III KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

3.1 KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

Tabel 3.1.1 Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan
1.	Promosi Kesehatan (Promkes)	a. Memberikan edukasi pasien dan keluarga tentang HIV/AIDS b. Melakukan penyuluhan di ruang tunggu c. Menyediakan media untuk KIE (poster dan leaflet)
2.	Penemuan kasus HIV/AIDS a. Skrining HIV/AIDS b. Konseling pada pasien HIV/AIDS c. Identifikasi IMS pada pasien HIV/AIDS d. Skrining HIV/AIDS notifikasi pasangan e. Monitoring penelusuran kontak	a. Melakukan skrining HIV/AIDS (Demam yang berkelanjutan, Penurunan berat badan drastis , Diare Kronis, Candidiasis, Kelainan kulit dan mukosa, Batuk kronis atau TBC), skrining dilakukan di IGD, rawat jalan, dan rawat inap. Skrining menggunakan form skrining HIV/AIDS b. Melakukan konseling pada pasien HIV/AIDS dengan hasil Reaktif c. Melakukan skrining TPHA pada pasien HIV/AIDS (ruam ruam di tangan, luka pada kelamin, dll) d. Melakukan identifikasi pasangan kontak erat e. Melakukan investigasi pasien LTFU (Lost to Follow-Up)
3.	Penanganan kasus HIV/AIDS a. Tata laksana IO pada HIV/AIDS b. Pemberian Profilaksis c. Pengobatan IMS d. Terapi ARV e. Pemantauan kepatuhan dan Viral Load f. Rujukkan bila diperlukan	a. Melakukan skrining penyakit penyerta (IMS) b. Memberikan profilaksis pada pasien anak dan dewasa c. Memberikan pengobatan IMS pada pasien HIV/AIDS yang hasil TPHA Reaktif d. Memberikan pengobatan ARV pada pasien HIV/AIDS e. Melakukan pemantauan kepatuhan dan cek Viral Load berkala sesuai ketentuan f. Melakukan rujukkan keluar sesuai kebutuhan pasien

4.	Survailens (pencatatan dan pelaporan)	a. Mencatat kasus HIV/AIDS (suspek dan terkonfirmasi) b. Mencatat pelaporan melalui sistem nasional (SIHA 2.1) c. Menganalisa data HIV/AIDS (tren kasus HIV/AIDS, angka keberhasilan pengobatan dan angka putus berobat)
5.	Manajemen Program	a. Koordinasi rujuk keluar dan rujuk masuk b. Pembinaan dan supervisi c. Pengelolaan logistik ARV, dan reagen

3.2 SASARAN

Tabel 3.2.1 Tabel Sasaran

No	Rincian Kegiatan	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Jenis	Target / Standar	Indikator keberhasilan	Ket
1.	Promkes Kesehatan (Promkes) a. Memberikan edukasi pasien dan keluarga tentang HIV/AIDS b. Melakukan penyuluhan di ruang tunggu c. Menyediakan media untuk KIE (poster dan leaflet)	Meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga mengenai HIV/AIDS, pengobatan, pencegahan penularan, serta kepatuhan terapi	Pasien HIV/AIDS dan keluarga.	Penyediaan Media Edukasi	100% pasien HIV/AIDS mendapatkan edukasi sebelum pulang atau setelah diagnosis ditegakkan	100% pasien memperoleh edukasi dan terdokumentasi pada rekam medis.	
2.	Penemuan kasus HIV/AIDS a. Skrining HIV/AIDS b. Konseling pada pasien HIV/AIDS c. Identifikasi IMS pada pasien HIV/AIDS d. Skrining HIV/AIDS notifikasi pasangan e. Monitoring penelusuran kontak	a. Menemukan kasus HIV sedini mungkin b. Membantu pasien memahami hasil pemeriksaan dan pengobatan c. Menemukan infeksi menular seksual yang menyertai HIV d. Memutus rantai penularan HIV.	a. Pasien dengan faktor risiko, pasien TB, IMS, ibu hamil, hepatitis, dan pasien sesuai indikasi klinis b. Pasien yang menjalani tes HIV c. Pasien HIV/AIDS d. Kontak erat pasien HIV	Skrining	a. 100% pasien dengan indikasi dilakukan skrining HIV sesuai pedoman b. 100% pasien mendapatkan konseling. c. Monitoring dilakukan setiap bulan	100% pasien indikasi diskriming dan terdokumentasi.	
3.	Penanganan kasus HIV/AIDS a. Tata laksana IO pada HIV/AIDS b. Pemberian Profilaksis c. Pengobatan IMS	menurunkan komplikasi akibat infeksi oportunistik	a. Pasien HIV/AIDS dengan IO. b. Pasien HIV/AIDS sesuai indikasi	Pelayanan Klinis	100% pasien mendapatkan terapi sesuai pedoman nasional	Kepatuhan tata laksana 100%	

	d. Terapi ARV e. Pemantauan kepatuhan dan Viral Load f. Rujukkan bila diperlukan		c. Pasien HIV dengan IMS d. Seluruh pasien HIV yang memenuhi indikasi				
4.	Survailens (pencatatan dan pelaporan)	a. Menjamin ketersediaan data yang akurat b. Memenuhi kewajiban pelaporan nasional c. Mengetahui tren kasus dan capaian indikator program.	Seluruh kasus HIV/AIDS.	Pencatatan dan pelaporan	a. 100% kasus dicatat pada register HIV/AIDS b. Laporan dikirim tepat waktu setiap bulan c. Analisis dilakukan minimal setiap triwulan	Kelengkapan pencatatan 100% a. Ketepatan waktu pelaporan mencapai 100% b. Tersedia laporan analisis beserta rencana tindak lanjut	
5.	Manajemen Program	a. Meningkatkan koordinasi antar unit pelayanan b. Mengetahui capaian indikator pelayanan dan mutu program.	Tim HIV/AIDS	Koordinasi	Minimal 1 kali setiap triwulan.	100% rapat terlaksana sesuai jadwal dan terdapat notulen serta RTL	

3.3 CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

Tabel 3.3.1 Tabel Cara Melaksanakan Kegiatan

No.	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti pelaksanaan	Ket
1.	Promosi kesehatan (Promkes)	a. Memberikan edukasi pasien dan keluarga tentang HIV/AIDS b. Melakukan penyuluhan di ruang tunggu c. Menyediakan media untuk KIE (poster dan leaflet)	Edukasi individu, penyuluhan kelompok, komunikasi interpersonal, konseling	Leaflet, poster, banner	Edukasi setiap hari, penyuluhan 1 kali/bulan, evaluasi setiap triwulan	a. Leaflet dan poster tentang HIV/AIDS b. Daftar hadir c. foto saat mengedukasi serta foto saat penyuluhan	
2.	Penemuan kasus HIV/AIDS	a. Melakukan skrining HIV sesuai indikasi klinis b. Melaksanakan konseling pra dan pasca tes HIV c. Melakukan identifikasi IMS pada pasien HIV/AIDS d. Melaksanakan partner notification e. Melaksanakan penelusuran kontak	a. Skrining, b. Konseling VCT/PITC, pemeriksaan laboratorium, wawancara, c. penelusuran kontak	Form skrining HIV	Dilaksanakan setiap hari sesuai indikasi, monitoring setiap bulan	Form skrining	
3.	Penanganan kasus HIV/AIDS	a. Tata laksana infeksi oportunistik b. Memberikan profilaksis sesuai indikasi	Pemeriksaan klinis, terapi, konseling, monitoring, koordinasi	pedoman terapi ARV	Pelayanan setiap hari, monitoring kepatuhan setiap	E-Rekam medis	

		c. Monitoring kepatuhan ARV d. Melaksanakan rujukan bila diperlukan	multidisiplin, rujukan.		kunjungan, evaluasi setiap bulan		
4.	Survailens (pencatatan dan pelaporan)	a. Melakukan pencatatan seluruh kasus HIV/AIDS pada register b. Menginput data ke SIHA sesuai ketentuan c. Menyusun laporan bulanan dan triwulan	Pencatatan, pelaporan, validasi data, monitoring dan evaluasi.	Register HIV/AIDS, aplikasi SIHA	Pencatatan setiap hari, pelaporan setiap bulan, analisis setiap triwulan	Register HIV, bukti pelaporan SIHA, laporan bulanan/triwulan	
5.	Manajemen Program	a. Menyusun program kerja tahunan HIV/AIDS b. Melaksanakan rapat koordinasi tim HIV/AIDS c. Monitoring logistik ARV, reagen, dan alat kesehatan	Rapat koordinasi, monitoring, audit internal, supervisi, evaluasi program	Program kerja, SK Tim HIV/AIDS, SOP, pedoman pelayanan	Program kerja 1 kali/tahun, rapat setiap triwulan, monitoring setiap bulan, audit 1 kali/tahun, pelatihan minimal 1 kali/tahun	Program kerja tahunan	

3.4 JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Tabel 3.4.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	KEGIATAN	BULAN												Tempat	PIC	Sumber dana
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Promkes a. Memberikan edukasi pasien dan keluarga tentang HIV/AIDS b. Melakukan penyuluhan di ruang tunggu c. Menyediakan media untuk KIE (poster dan leaflet)													RS	Petugas HIV/AIDS /promkes	
2	Penemuan kasus HIV/AIDS a. Melakukan skrining HIV sesuai indikasi klinis b. Melaksanakan konseling pra dan pasca tes HIV c. Melakukan identifikasi IMS pada pasien HIV/AIDS d. Melaksanakan partner notification e. Melaksanakan penelusuran kontak													RS	Petugas HIV/AIDS	
3.	Penanganan kasus HIV/AIDS a. Tata laksana infeksi oportunistik b. Memberikan profilaksis sesuai indikasi c. Monitoring kepatuhan ARV													RS	Dokter/ Perawat	

	d. Melaksanakan rujukan bila diperlukan																
4.	Survailens (pencatatan dan pelaporan) a. Melakukan pencatatan seluruh kasus HIV/AIDS pada register b. Menginput data ke SIHA sesuai ketentuan c. Menyusun laporan bulanan dan triwulan														RS	Dokter, Perawat, Petugas Lab	
5.	Manajemen Program a. Menyusun program kerja tahunan HIV/AIDS b. Melaksanakan rapat koordinasi tim HIV/AIDS c. Monitoring logistik ARV, reagen, dan alat kesehatan														RS	Dokter, Perawat, Petugas Lab	

3.5 Kebutuhan Anggaran

3.5.1 Tabel Kebutuhan Anggaran

N O	BAHAN	RATA /BULAN	KEBUTUHAN		HARGA SATUAN	TOTAL Rp
			1 TAHUN			
1.	Leaflet dan poster	15	180	Lembar	1000	180.000
2.	ATK dan format HIV/AIDS	10	120	Set	5000	60.000
3.	Internet / data	1	12	Paket	30.000	360.000
4.	Format skrining	30	360	Lembar	1000	360.000
5.	Laboratorium	10	120	Paket	50.000	600.000
6.	ARV	20	240	Paket	0	0
7.	Handschone	30	360	Pcs	5.000	1.800.000
8.	Hand rub	1	12	Botol	30.000	360.000
9.	Rapat evaluasi	20	240	Porsi	25.000	300.000
					Total	4.020.000

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi (Monev) program pelayanan HIV/AIDS merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk menilai pelaksanaan program, pencapaian indikator, serta kualitas pelayanan HIV/AIDS di rumah sakit. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk menilai kinerja program pelayanan HIV/AIDS dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

4.1 Monitoring dengan melakukan supervisi

4.1.1 Tabel Monitoring dengan melakukan supervisi

NO	Aspek yang di supervisi	Standard /Target	Sesuai Standar (V)	Tidak sesuai standar (V)	Catatan temuan
1.	Promosi Kesehatan (Promkes)	a. Edukasi $\geq 2x$ /tahun, dokumentasi tersedia b. Media KIE (poster, leaflet, banner) tersedia dan diperbarui minimal 1 kali/tahun			
2.	Penemuan kasus HIV/AIDS	100% pasien dengan indikasi dilakukan skrining HIV sesuai pedoman nasional			
3.	Penanganan kasus HIV/AIDS	100% pasien yang memenuhi syarat mendapatkan terapi ARV sesuai pedoman nasional			
4.	Survailens (pencatatan dan pelaporan)	100% kasus HIV/AIDS dicatat pada register pelayanan			
5.	Manajemen Program	Program kerja HIV/AIDS tersedia dan disahkan setiap tahun			

BAB V PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pencatatan dan pelaporan program pelayanan HIV/AIDS adalah kegiatan sistematis yang dilakukan untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan pelayanan HIV/AIDS, mulai dari penemuan kasus, pengobatan, pencegahan, hingga pemantauan pasien. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan data pelayanan HIV/AIDS lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaporan dilakukan sesuai standar nasional HIV/AIDS dan ketentuan akreditasi Rumah Sakit :

5.1 Pelaporan Internal

1. Disampaikan kepada kepala unit HIV/AIDS dan manajemen rumah sakit;
2. Meliputi jumlah kasus, kepatuhan pengobatan, cakupan imunisasi, dan pelaksanaan PPI;
3. Dilakukan bulanan dan triwulan.

5.2 Pelaporan Eksternal

1. Disampaikan ke Dinas Kesehatan / SIHA 2.1 sesuai format nasional;
2. Meliputi indikator kinerja utama ;
 - a. Kelengkapan laporan PPI dan Promkes
 - b. Dilakukan bulanan dan tahunan

BAB VI PENUTUP

Program kerja pelayanan HIV/AIDS di Rumah Sakit Prima Husada ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab dan pelayanan yang lebih baik

Mengetahui
Ketua Tim HIV/AIDS



dr. Cameleia Diah Setyorini, Sp. PD

Pasuruan, 01 Januari 2026
Perawat Penanggung Jawab
Tim HIV/AIDS



Vira Agustin Sintia Putri, AMd. Kep

Menyetujui,
Direktur RS Prima Husada Sukorejo



(Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep., M.Kep)